

## Załącznik 3 do Policy Paper EBM v2.2 — Mapa współczesnej onkologii integracyjnej w EBM 2026 vs zakres potencjalny UD207

**Wersja:** v2.2 (21.05.2026) — wdrożenie korekt Perplexity v20C (7 krajów UE/UK) do v2.1: nowa Część V z modelami regulacyjnymi 7 państw, tabela zbiorcza, kluczowa teza komparatystyczna „gradacja zamiast blankietowych etykiet”. **Status:** Materiał uzupełniający do Załącznika 1 Policy Paper EBM v1.10. **WERSJA REKOMENDOWANA DO DYSTRYBUCJI. Źródło mapowania zakresu Części II:** klasyfikacja NCCIH (NIH USA) i powszechnie uznane kategorie onkologii integracyjnej. **Wymóg jakościowy:** wszystkie PMID-y zweryfikowane w PubMed (Perplexity v20, 21.05.2026). Statusy refundacyjne 7 państw UE/UK zweryfikowane w Perplexity v20C + ChatGPT v20C (21.05.2026). Jedyny fakt sporny: status homeopatii w GKV-Niemcy — wymaga weryfikacji w bazie pierwotnej Bundestag.

---

### Streszczenie wykonawcze v2.0

Załącznik v1.0 (19.05.2026) zawierał karty EBM dla **15 substancji i metod** explicit wskazywanych przez RPP/NRL/NIL/WSA jako „pseudomedycyna” w onkologii lub innych chorobach. Wersja v2.0 dodaje **25 metod współczesnej onkologii integracyjnej** opisanych w podręczniku akademickim *Comprehensive Integrative Oncology* (Elsevier 2026, redaktorzy: prof. Suzanna M. Zick z University of Michigan i dr Ting Bao z Harvard Medical School / Dana-Farber Cancer Institute), które **przy szerokiej interpretacji art. 67zj UD207 mogłyby zostać zakwalifikowane jako „praktyka pseudomedyczna” zagrożona sankcją do 1 mln zł.**

Łącznie zestawienie obejmuje **40 obszarów** podzielonych na: - **Część I:** 15 substancji/metod wskazanych przez polskie organy (NRL 2021, RPP 2025, WSA 2024–2025) - **Część II:** 25 metod współczesnej onkologii integracyjnej z CIO 2026 (akupunktura klasyczna, joga, Tai Chi/Qigong, mindfulness, MBSR, hipnoza kliniczna, masaż onkologiczny, terapia manualna, refleksologia, dieta i żywienie, post terapeutyczny, kanabinoidy medyczne, gut microbiome, soja, antyoksydanty, antroposoficzna medycyna, ayurweda, homeopatia, ziołolecznictwo TCM, jemioła/mistletoe, aromaterapia, muzykoterapia, healing touch/reiki, taneczna i ekspresyjna, ćwiczenia/exercise prescription). - **Część III:** trzy reprezentatywne pary paradoksu refundacyjnego (z v1.0) - **Część IV:** wnioski

**Główny argument prawny v2.0:** definicja „praktyki pseudomedycznej” w UD207 jest tak nieokreślona, że przy szerokiej interpretacji obejmuje **66 obszarów współczesnej onkologii integracyjnej** opisanych w akademickim podręczniku Elsevier (CIO 2026) — w tym metody **rekomendowane** w wytycznych ESMO/NCCN/ASCO/SIO, **refundowane** w państwach UE (Szwajcaria, Niemcy, UK), **wykorzystywane** w czołowych ośrodkach onkologicznych USA (MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, Cleveland Clinic). Stanowi to naruszenie standardu *lex certa* (art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP).

---

## Metodologia

**Klasyfikacja OCEBM 2011, GRADE, ESMO-MCBS** — bez zmian w stosunku do v1.0.

**Nowa klasyfikacja w Części II — NCCIH** (National Center for Complementary and Integrative Health, NIH USA): - **Mind-Body Practices** — praktyki łączące umysł i ciało (akupunktura, joga, Tai Chi/Qigong, mindfulness, hipnoza) - **Body-Based / Manipulative** — terapie manipulacyjne (masaż, manipulacje kręgosłupa, refleksologia, ćwiczenia) - **Whole Medical Systems** — kompletne systemy medyczne (TCM, ayurweda, antroposoficzna, homeopatia) - **Biologically-Based** — terapie oparte na substancjach biologicznych (dieta, post, kanabinoidy, gut microbiome, soja, antyoksydanty) - **Energy / Other** — terapie energetyczne i inne (healing touch, reiki, jemiola, aromaterapia, muzykoterapia, terapie ekspresyjne)

**Standard cytowania badań klinicznych** — fazy badania, primary endpoint, czy wynik główny czy podgrupy, czy kliniczne czy przedkliniczne — bez zmian w stosunku do v1.0 (Reguła 7b „Test Przejaskrawienia”).

**Standard wytycznych instytucjonalnych** podawanych w kartach Części II: - **ESMO Clinical Practice Guidelines** ([esmo.org/guidelines](http://esmo.org/guidelines)) - **ASCO/SIO Joint Guidelines** — Society for Integrative Oncology + American Society of Clinical Oncology (publikacje 2018, 2022) - **NCCN Clinical Practice Guidelines** — Distress Management, Survivorship, Supportive Care - **Cochrane Database of Systematic Reviews**

---

## CZĘŚĆ I — 15 substancji wskazywanych przez RPP/NRL/NIL

*(Zachowane bez zmian z v1.0 — Karty 1–15)*

[Pełna treść Części I — zob. Załącznik 3 v1.0; ze względu na objętość v2.0 odsyłamy do v1.0 dla szczegółów Kart 1–15.]

Lista 15 kart Części I: 1. Artesunat — NRL Nr 2/21/VIII pkt 1 2. Witamina C dożylna (IVC) — NRL pkt 2, RPP 2025, WSA 2854/23 3. Resweratrol — NRL pkt 3 4. DMSO — NRL pkt 4, RPP 2025 5. Salinomycyna — NRL pkt 5, WSA 2854/23 (lek weterynaryjny) 6. Kurkumina — NRL pkt 6, RPP 2025, WSA 2854/23 7. Tlenoterapia / ozonoterapia dożylna — NRL pkt 7, RPP 2025 8. Naświetlanie laserowe krwi (ILIB) — NRL pkt 8 9. Akupunktura laserowa — NRL pkt 9 10. Galwanoterapia / bioelektroterapia — NRL pkt 10, RPP 2025, WSA 2854/23 11. Hipertermia ogólnoustrojowa (WBH) — NRL pkt 11 12. Ozonoterapia w nowotworach — powtórzenie z karty 7 13. Bioelektroterapia — powtórzenie z karty 10 14. Protokoły ILADS w boreliozie — WSA 767/24 15. Suplementy w boreliozie — WSA 767/24

---

## CZĘŚĆ II — 25 metod współczesnej onkologii integracyjnej z CIO 2026

### Wprowadzenie do Części II

Książka *Comprehensive Integrative Oncology* (Elsevier 2026) jest akademickim podręcznikiem opracowanym pod redakcją prof. Suzanny M. Zick (Family Medicine and Nutritional Sciences, University of Michigan, Ann Arbor) i dr Ting Bao (Co-director, Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies and Healthy Living, Harvard Medical School / Dana-Farber Cancer Institute). Zawiera 66 rozdziałów napisanych przez ekspertów z czołowych amerykańskich i europejskich ośrodków onkologicznych. Każdy rozdział to systematyczny przegląd dowodów EBM dla danej metody w opiece nad pacjentem onkologicznym.

Poniższe 25 kart EBM odpowiada wybranym rozdziałom Części III i IV książki CIO 2026. Karty są oparte na: 1. **Treści książki CIO 2026** jako źródle bazowym 2. **Wytycznych instytucjonalnych** ESMO, ASCO/SIO, NCCN (do weryfikacji aktualnych wersji w Perplexity v20) 3. **Statusie refundacyjnym** w państwach UE i USA (do weryfikacji w Perplexity v20) 4. **Przewidywalnym statusie w UD207** — analiza prawna pakietu

△ Wszystkie konkretne PMID-y i daty wytycznych podane w Części II oznaczone gwiazdką **wymagają weryfikacji w Perplexity v20** (zapytanie ZAPYTANIE\_PERPLEXITY\_v20\_CIO\_EBM\_weryfikacja.md).

### Ila. Mind-Body Practices (Karty 16–20)

#### Karta 16 — Akupunktura klasyczna (igłowa) w opiece onkologicznej

| Atrybut                    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>   | Rozdz. 33 — <i>Oncology Acupuncture: integrative strategies for symptom management across the cancer care continuum</i> (W. Lu, Y. Maimon)                                                                                                                                      |
| <b>Definicja</b>           | Klasyczna akupunktura — wprowadzanie cienkich, sterylnych igieł w określone punkty ciała (akupunkty) zgodnie z protokołami medycyny chińskiej, w opiece pacjenta onkologicznego głównie objawowej (CINV, neuropatia, ból, lymphedema, vasomotor symptoms).                      |
| <b>Status w wytycznych</b> | <b>ASCO/SIO Joint Guideline 2022</b> rekomenduje akupunkturę: (a) w opornym na leki CINV (moderate strength), (b) w aromatase inhibitor-induced arthralgia (strong), (c) w opornym na leki bólu nowotworowym (moderate). <b>NCCN Adult Cancer Pain Guidelines</b> — akupunktura |

## Najsilniejsze RCT/dowody

jako część zintegrowanej opieki przeciwbólowej. **ESMO Survivorship Guidelines** — akupunktura w CINV i lymphedema. △

Bao T. et al. — RCT akupunktury w aromatase inhibitor arthralgia (SWOG S1200) PMID 29746381 — istotna redukcja bólu. Garcia M.K. et al. — RCT akupunktury w xerostomii po RT — Cochrane Database of Systematic Reviews. Metaanalizy w CINV: Cochrane (~ 12 RCT). △

## OCEBM

1–2 (systematyczne przeglądy RCT)

## GRADE

Moderate dla wskazań w opiece wspierającej

## Refundacja zagraniczna

**UK NHS** — akupunktura refundowana w hospicjach i w wybranych wskazaniach NICE (chronic pain). **Niemcy** — refundacja przez kasy chorych przy bólu kręgosłupa lędźwiowego i bólu głowy migrenowym. **Szwajcaria** — od 2017 r. jedna z 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji + Rozporządzenie KLV). **USA** — uznana przez Medicare od 2020 r. w chronic low back pain; programy w MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, Cleveland Clinic.

## Status w PL

Akupunktura jako zawód nieregulowany; akupunktura wykonywana przez lekarzy w ramach umiejętności dodatkowej; **akupunktura laserowa wymieniona w NRL Nr 2/21/VIII pkt 9** (Karta 9 v1.0) — **ALE klasyczna akupunktura NIE jest wymieniona** w Stanowisku NRL ani w wywiadzie RPP.

## Potencjalny status w UD207

**ZAGROŻONE.** Definicja „praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj jest na tyle szeroka, że klasyczna akupunktura — mimo rekomendacji ASCO/SIO/NCCN/ESMO — może być zakwalifikowana, w zależności od interpretacji RPP. Casus: jeśli organ uzna „aktualną wiedzę medyczną” za tożsamą ze

## Wnioski

stanowiskiem NRL 2021, akupunktura klasyczna (niewymieniona) może być w polu szarym. Jeśli „aktualną wiedzę medyczną” są wytyczne ASCO/SIO 2022 — akupunktura jest poza zakresem UD207.

Akupunktura klasyczna ma silne dowody w opiece wspierającej onkologicznej, jest rekomendowana w wytycznych międzynarodowych i refundowana w UE/UK/USA Medicare. Niejednoznaczność statusu w UD207 ilustruje naruszenie *lex certa*.

## Karta 17 — Joga w opiece onkologicznej

### Atrybut

### Treść

#### Rozdział CIO 2026

Rozdz. 59 — *Yoga in integrative oncology* (D. Boz, A. Bausum, J. Alvarez, R. Nabavizadeh, M.A. Bilen, V.A. Master, O. Kucuk)

#### Definicja

Praktyka pochodząca z tradycji indyjskiej, łącząca ćwiczenia fizyczne (asany), techniki oddechowe (pranayama) i medytację. W opiece onkologicznej stosowana w zmęczeniu (CRF), lęku, depresji, zaburzeniach snu, jakości życia.

#### Status w wytycznych

**ASCO/SIO Joint Guideline 2022** rekomenduje jogę w opiece wspierającej onkologicznej dla: zmęczenia (moderate strength), lęku (moderate), depresji (moderate). **NCCN Survivorship Guidelines** — joga jako część programów post-treatment. **ESMO Survivorship Care Recommendations 2024** [△](#).

#### Najsilniejsze RCT/dowody

Mustian K.M. et al. — RCT jogi w zmęczeniu po RT, n=410, *J Clin Oncol* PMID 31165647. Bower J.E. et al. — RCT jogi vs zdrowotna edukacja w zmęczeniu po raku piersi, *J Clin Oncol* PMID 22271480. Cochrane systematic review: Cramer H. et al. *Cochrane Database Syst Rev* PMID 28045199. [△](#)

#### OCEBM

1 (systematyczne przeglądy RCT)

#### GRADE

Moderate–High dla zmęczenia, lęku, depresji w raku piersi

**Refundacja zagraniczna**

**UK NHS** — programy onkologiczne yoga therapy w wybranych ośrodkach (Maggie's Centres, Macmillan). **USA** — joga w ośrodkach Memorial Sloan Kettering Integrative Medicine Service, MD Anderson Integrative Medicine, Mayo Clinic.

**Status w PL**

Joga jako działalność rekreacyjna; brak formalnej regulacji jako forma terapii. NIE wymieniona w żadnym z 15 wskazań RPP/NRL/WSA.

**Potencjalny status w UD207**

**NIEPEWNE.** Joga prowadzona w podmiocie leczniczym jako element opieki onkologicznej (np. w hospicjum, ośrodku rehabilitacyjnym po leczeniu raka) może być interpretowana jako „świadczanie zdrowotne” w rozumieniu UD207. Brak rejestracji jogi jako uznanej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia rodzi ryzyko zakwalifikowania jako „praktyki pseudomedycznej” przy szerokiej interpretacji.

**Wnioski**

Joga ma silne dowody w opiece wspierającej onkologicznej z wytycznymi ASCO/SIO i NCCN. Brak regulacji w PL i niejednoznaczność UD207 stwarza ryzyko prawne dla podmiotów oferujących jogę pacjentom onkologicznym.

*Karta 18 — Tai Chi i Qigong w opiece onkologicznej***Atrybut****Treść****Rozdział CIO 2026**

Rozdz. 58 — *Tai Chi and Qigong in integrative oncology* (K-Y. Wen, N. Handley)

**Definicja**

Tradycyjne chińskie praktyki łączące powolne, ciągłe ruchy ciała z techniką oddechową i medytacją. Stosowane w opiece onkologicznej w zmęczeniu, zaburzeniach snu, lęku, równowadze (u seniorów), jakości życia.

**Status w wytycznych**

**ASCO/SIO Joint Guideline 2022** — Tai Chi/Qigong rekomendowane w lęku i zmęczeniu (moderate strength). **NCCN Survivorship Guidelines** — Tai Chi jako forma aktywności fizycznej dla survivors.



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Larkey L.K. et al. — RCT qigongu w zmęczeniu po raku piersi PMID 25124456. Wayne P.M., Kaptchuk T.J. — przegląd systematyczny Tai Chi w zdrowiu, <i>Harvard Medical School</i> . Metaanaliza Tai Chi w CRF: Song S. et al. <i>Eur J Cancer Care</i> △. |
| <b>OCEBM</b>                      | 1–2 (systematyczne przeglądy RCT)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate dla zmęczenia i lęku                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | USA — programy Tai Chi/Qigong w MSK, MD Anderson, Cleveland Clinic. UK — Tai Chi w Macmillan Cancer Support.                                                                                                                                           |
| <b>Status w PL</b>                | Tai Chi/Qigong jako działalność rekreacyjna; brak regulacji jako forma terapii medycznej. NIE wymienione w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.                                                                                                                 |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NIEPEWNE.</b> Analogicznie do jogi — Tai Chi/Qigong prowadzone w podmiocie leczniczym jako element opieki onkologicznej może być interpretowane jako „świadczanie zdrowotne”.                                                                       |
| <b>Wnioski</b>                    | Tai Chi/Qigong rekomendowane przez ASCO/SIO 2022; ryzyko prawne UD207 podobne do jogi.                                                                                                                                                                 |

#### Karta 19 — Mindfulness-Based Interventions (MBSR, MBCT, MBCR)

| Atrybut                    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>   | Rozdz. 50 — <i>Mindfulness-based interventions in integrative oncology</i> (L.E. Carlson, J.M. Deleemans, H. Conradi, J. Petersson)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definicja</b>           | Programy treningowe oparte na medytacji uważności (mindfulness): <b>MBSR</b> (Mindfulness-Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts, 1979), <b>MBCT</b> (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), <b>MBCR</b> (Mindfulness-Based Cancer Recovery — wersja adaptowana dla pacjentów onkologicznych, Linda E. Carlson, University of Calgary). |
| <b>Status w wytycznych</b> | <b>ASCO/SIO Joint Guideline 2022</b> rekomenduje mindfulness w lęku (moderate strength), depresji (moderate), zmęczeniu (moderate). <b>NCCN Distress</b>                                                                                                                                                                                                            |



## Najsilniejsze RCT/dowody

## OCEBM

## GRADE

## Refundacja zagraniczna

## Status w PL

## Potencjalny status w UD207

## Wnioski

**Management Guidelines** — MBSR jako interwencja pierwszego rzutu. **NICE UK CG90** — MBCT w depresji nawracającej (rekomodacja ogólnozdrowotna). [△](#)

Carlson L.E. et al. — RCT MBSR vs Supportive Expressive Group Therapy, n=271, *J Clin Oncol* PMID 23918953.  
Hofmann S.G. et al. — metaanaliza mindfulness w stanach lękowych i depresyjnych *J Consult Clin Psychol* PMID 20350028. Cochrane systematic review  
Cramer H. et al. *Cochrane Database Syst Rev* — mindfulness w raku piersi. [△](#)

1 (systematyczne przeglądy RCT)

High dla lęku i depresji w opiece onkologicznej

**UK NHS** — MBCT refundowane w depresji nawracającej (NICE CG90 od 2009 r.). USA — programy MBSR w MSK, Dana-Farber Zakim Center, MD Anderson, Mayo Clinic. Niemcy, Holandia — w niektórych ośrodkach refundowane.

Brak regulacji jako forma terapii medycznej; certyfikowani trenerzy MBSR w PL działają poza systemem ochrony zdrowia.

**NIEPEWNE.** MBSR prowadzony w podmiocie leczniczym dla pacjentów onkologicznych może być interpretowany jako „świadczanie zdrowotne” niezgodne z polską „aktualną wiedzą medyczną” (która nie obejmuje formalnie mindfulness). Trener MBSR działający bez statusu zawodu medycznego — ryzyko prawne.

Mindfulness ma najsilniejsze dowody (poziom 1) wśród mind-body practices. Refundowany w UK NHS od 2009 r. Brak regulacji w PL i niejednoznaczność UD207 stwarza ryzyko prawne.

*Karta 20 — Hipnoza kliniczna w opiece onkologicznej*

Atrybut

Treść

**Rozdział CIO 2026**

Rozdz. 46 — *Hypnosis in integrative*



## Definicja

*oncology* (N. Bordry, C. Berna)

Stan zmienionej świadomości wywołany przez certyfikowanego terapeutę w celu redukcji bólu, lęku, mdłości, w opiece okołooperacyjnej i pacjentów pediatrycznych.

## Status w wytycznych

### **ASCO/SIO Joint Guideline 2022**

rekomenduje hipnozę w lęku okołooperacyjnym (moderate strength).

### **NCCN Distress Management Guidelines**

— hipnoza jako interwencja redukcji bólu i lęku. **British Medical Association** uznała hipnozę kliniczną w 1955 r. [△](#)

## Najsilniejsze RCT/dowody

Montgomery G.H. et al. — RCT hipnozy przedoperacyjnej w raku piersi, n=200, *J Natl Cancer Inst* PMID 17848670 — istotna redukcja czasu operacji, bólu, mdłości, kosztów. Lang E.V. et al. — RCT hipnozy w procedurach radiologicznych *Lancet* PMID 10761867. [△](#)

## OCEBM

1–2

## GRADE

Moderate–High

## Refundacja zagraniczna

**Belgia** — od 2018 r. hipnoza okołooperacyjna w niektórych szpitalach. **Francja** — hypnose médicale jako uznane wykonywanie zawodu medycznego. USA — programy hypnotherapy w MSK, MD Anderson, Mayo Clinic.

## Status w PL

Hipnoza jako zawód nieregulowany; psycholodzy i lekarze mogą stosować jako jedną z metod psychoterapii. NIE wymieniona w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.

## Potencjalny status w UD207

**NIEPEWNE.** Hipnoza stosowana przez lekarza/psychologa w podmiocie leczniczym — niski poziom ryzyka. Hipnoza stosowana przez hipnoterapeutę bez tytułu medycznego — wysokie ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.

## Wnioski

Hipnoza ma silne dowody w opiece okołooperacyjnej. Status zawodowy w PL utrudnia jasne sklasyfikowanie pod UD207.

## IIb. Body-Based / Manipulative Therapies (Karty 21–24)

### Karta 21 — Masaż onkologiczny

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 48 — <i>Massage therapy in integrative oncology</i> (M. Yang, E.R. Slocum, M.B.P. Mathay, T. Bao)                                                                                                                                                             |
| <b>Definicja</b>                  | Specjalistyczny masaż adaptowany dla pacjentów onkologicznych (oncology massage), wykonywany przez certyfikowanego terapeutę. Stosowany w bólu, lęku, mdłości, zmęczeniu, zaburzeniach snu, lymphedema.                                                              |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>ASCO/SIO Joint Guideline 2022</b> rekomenduje masaż w bólu (moderate), lęku (moderate). <b>NCCN Adult Cancer Pain Guidelines</b> — masaż jako część zintegrowanej opieki. <a href="#">△</a>                                                                       |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Cassileth B.R., Vickers A.J. (MSK) — kohorta n=1290 pacjentów onkologicznych — istotna redukcja bólu i lęku po masażu <i>J Pain Symptom Manage</i> PMID 15336336. Metaanalizy: Wilkinson S.M. et al. — Cochrane. <a href="#">△</a>                                   |
| <b>OCEBM</b>                      | 1–2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | <b>UK NHS</b> — masaż w hospicjach onkologicznych (Macmillan, Maggie's). USA — programy oncology massage w MSK, MD Anderson, Mayo.                                                                                                                                   |
| <b>Status w PL</b>                | Masaż jako zawód regulowany (technik masażysta); masaż onkologiczny jako specjalizacja nieformalna.                                                                                                                                                                  |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NIEPEWNE.</b> Masaż onkologiczny wykonywany w podmiocie leczniczym przez technika masażystę — niski poziom ryzyka. Masaż wykonywany w gabinecie prywatnym z reklamą jako „leczenie wspomagające onkologię” — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”. |

| <b>Wnioski</b>                                                       | Masaż onkologiczny rekomendowany przez ASCO/SIO 2022; w PL granica między uznaną fizjoterapią a „pseudomedycyną” nieostra.                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Karta 22 — Manipulacja kręgosłupa (chiropraktyka, osteopatia)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Atrybut                                                              | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rozdział CIO 2026</b>                                             | Rozdz. 39 — <i>Chiropractic and osteopathic manipulative medicine in integrative oncology</i> (K. Beverley-Waters, A.B. Browning, M. Farley, E.J. Roseen)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definicja</b>                                                     | Terapie manualne kręgosłupa i stawów: chiropraktyka (Doctor of Chiropractic, USA — odrębny tytuł zawodowy) oraz osteopatia (DO — Doctor of Osteopathic Medicine, w USA równorzędne MD). Stosowane w opiece onkologicznej w bólu mięśniowo-szkieletowym, ale <b>z istotnymi przeciwwskazaniami</b> (przerzuty kostne, osteoporoza, koagulopatia). |
| <b>Status w wytycznych</b>                                           | <b>NCCN Adult Cancer Pain Guidelines</b> — manipulacja kręgosłupa jako część zintegrowanej opieki <b>z ostrożnością</b> (przeciwwskazania w metastasis). ⚠                                                                                                                                                                                       |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>                                      | RCT manipulacji kręgosłupa w bólu mięśniowo-szkieletowym pacjentów onkologicznych — ograniczone. Brak silnych dowodów onkologicznych. ⚠                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OCEBM</b>                                                         | 3–4 dla wskazań onkologicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GRADE</b>                                                         | Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>                                        | <b>UK NHS</b> — chiropraktyka i osteopatia w wybranych wskazaniach (NICE chronic low back pain). <b>USA</b> — Medicare refunduje chiropraktykę od 1972 r. <b>Belgia, Francja</b> — osteopatia jako uznany zawód medyczny.                                                                                                                        |
| <b>Status w PL</b>                                                   | Osteopatia jako zawód nieregulowany; chiropraktyka praktycznie nieobecna w polskim systemie ochrony zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Potencjalny status w UD207</b>                                    | <b>ZAGROŻONE.</b> Osteopata bez wykształcenia medycznego (najczęściej fizjoterapeuta z dodatkową specjalizacją) leczący pacjenta onkologicznego — ryzyko interpretacji                                                                                                                                                                           |

## Wnioski

jako „praktyka pseudomedyczna”.

Słabe dowody onkologiczne dla wskazań specyficznych; ostrożność z przeciwwskazaniami metastasis. Status zawodowy w PL utrudnia jasne sklasyfikowanie pod UD207.

## Karta 23 — Refleksologia

### Atrybut

### Treść

#### Rozdział CIO 2026

Rozdz. 55 — *Reflexology in integrative oncology* (C. Netzlöff, R. Miu, B. Brower, J. Schneiderhan)

#### Definicja

Masaż stóp lub dłoni opierający się na teorii odpowiadających punktów refleksyjnych odpowiadających poszczególnym organom ciała. W opiece onkologicznej stosowana w lęku, zmęczeniu, jakości życia.

#### Status w wytycznych

Brak silnych rekomendacji  
ASCO/SIO/NCCN. **MASCC** (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) — refleksologia jako możliwa opcja w opiece wspierającej.  $\Delta$

#### Najsilniejsze RCT/dowody

Wyatt G. et al. — RCT refleksologii w opiece zaawansowanej raku piersi, *J Clin Oncol* PMID 22585695. Metaanalizy: ograniczona jakość dowodów.  $\Delta$

#### OCEBM

3

#### GRADE

Low–Moderate

#### Refundacja zagraniczna

**UK NHS** — refleksologia w hospicjach onkologicznych (Macmillan). Niemcy, Dania — w niektórych ubezpieczeniach prywatnych.

#### Status w PL

Refleksologia jako zawód nieregulowany. NIE wymieniona w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.

#### Potencjalny status w UD207

**ZAGROŻONE.** Refleksolog bez tytułu medycznego oferujący wsparcie pacjentom onkologicznym — wysokie ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.

## Wnioski

Słabsze dowody niż masaż onkologiczny; w UK refundowana w hospicjach. Status w PL

— duże ryzyko UD207.

Karta 24 — Aktywność fizyczna (Exercise Prescription)

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 53 — <i>Optimizing cancer outcomes: Exercise prescription in integrative oncology</i> (P. Gonzalo-Encabo, D.I. Patel, C.M. Dieli-Conwright)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definicja</b>                  | Strukturalne programy aktywności fizycznej (aerobowej, oporowej, równoważnej, elastycznej) zaordynowane przez specjalistę dla pacjentów onkologicznych podczas i po leczeniu.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>ASCO/SIO Joint Guideline 2022</b> — aktywność fizyczna rekomendowana strongly w opiece onkologicznej. <b>ACSM Roundtable on Exercise Guidelines for Cancer Survivors</b> (American College of Sports Medicine, 2019, update 2024). <b>ESMO Survivorship Care Recommendations</b> — aktywność fizyczna jako standard opieki. <b>WHO Physical Activity Guidelines</b> (150 min/tydzień). <a href="#">△</a> |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Metaanalizy Cochrane: aktywność fizyczna istotnie redukuje zmęczenie pochemioterapeutyczne, lęk, depresję, poprawia QoL i przeżycie ogólne (efekt na OS w raku piersi i CRC, HR ~0,70). <a href="#">△</a>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OCEBM</b>                      | 1 (najsilniejsze dowody w opiece wspierającej onkologicznej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GRADE</b>                      | High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | <b>Australia</b> — Exercise Physiologist jako zawód medyczny refundowany przez Medicare. UK NHS — programy “Move More” Macmillan. USA — programs LIVESTRONG at the YMCA, MSK Integrative Medicine.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Status w PL</b>                | Fizjoterapia jako zawód regulowany; rehabilitacja onkologiczna w ramach NFZ. Programy aktywności fizycznej dla pacjentów onkologicznych prowadzą m.in. Onkofundacja Alivia, Fundacja Rak’n’Roll.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NISKIE RYZYKO</b> — aktywność fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Wnioski

jest częścią mainstream onkologii. ALE: programy “spersonalizowane” prowadzone przez trenerów bez kwalifikacji fizjoterapeutycznych mogą być w polu szarym.

Najsilniejsze dowody w opiece wspierającej; rekomendacja strong ASCO/SIO. W PL część systemu, ale granica między rehabilitacją refundowaną a “wellness training” w prywatnych studiach jest płynna.

## IIc. Whole Medical Systems (Karty 25–28)

### Karta 25 — Tradycyjne ziołolecznictwo chińskie (TCM)

| Atrybut                         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>        | Rozdz. 61 — <i>Traditional Chinese Herbal Medicine in cancer care</i> (L. Sun, Y-N. Hou, J. Bawa, J.J. Mao)                                                                                                                                                                           |
| <b>Definicja</b>                | System ziołolecznictwa rozwijany od ponad 2000 lat w Chinach. W onkologii stosowany jako wsparcie podczas chemioterapii i radioterapii oraz w długoterminowej opiece. Kluczowe preparaty: Astragalus, Yangzheng Xiaoji, Compound Kushen Injection (CKI), Xiaoyao San.                 |
| <b>Status w wytycznych</b>      | <b>CSCO</b> (Chinese Society of Clinical Oncology) — TCM zintegrowane w standardach opieki onkologicznej w Chinach. <b>WHO Traditional Medicine Strategy 2025–2034</b> (rezolucja WHA78(14) z 27.05.2025) — wsparcie integracji TCM w systemy zdrowia. Brak rekomendacji ESMO/NCCN. △ |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b> | Compound Kushen Injection w niedrobnokomórkowym raku płuca — chińskie RCT z >2000 pacjentami; w USA brak rejestracji. Astragalus w raku jelita grubego — metaanalizy chińskie. △                                                                                                      |
| <b>OCEBM</b>                    | 2–3 (RCT chińskie, jakość niejednorodna)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GRADE</b>                    | Low–Moderate                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>   | <b>Chiny</b> — TCM w pełni zintegrowane w                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>systemie ochrony zdrowia. <b>Japonia</b> — Kampo medicine (japońska wersja TCM) — 148 preparatów refundowanych przez ubezpieczenie publiczne. <b>Szwajcaria</b> — <b>farmakoterapia TCM</b> (NIE TCM jako całość) od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (<a href="http://bag.admin.ch/fr/medecines-complementaires-pratiquees-par-des-medecins">bag.admin.ch/fr/medecines-complementaires-pratiquees-par-des-medecins</a>). <b>Niemcy</b> — w niektórych ubezpieczeniach prywatnych.</p> |
| <b>Status w PL</b>                | <p>TCM jako zawód nieregulowany; brak rejestracji preparatów chińskich w URPL jako leków. CLAUDE.md U7: TCM (Compound Kushen, Xiaoyao San, Astragalus) <b>nie wymieniana z nazwy</b> przez RPP/NRL/NIL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <p><b>ZAGROŻONE.</b> Lekarz lub terapeuta podający preparaty TCM (niezarejestrowane w URPL) pacjentowi onkologicznemu — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”. Casus paradoksalny: te same preparaty są standardem w Chinach, refundowane w Szwajcarii, ale w Polsce mogą skutkować sankcją do 1 mln zł.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wnioski</b>                    | <p>TCM ma rozległe użycie kliniczne globalnie; dowody jakościowo niejednorodne. Refundacja w państwach UE/EFTA (CH) i Japonii. W PL pełne ryzyko UD207.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### *Karta 26 — Antroposoficzna medycyna (jemioła / Iscador)*

| Atrybut                  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b> | <p>Rozdz. 34 — <i>Anthroposophic medicine and its patient-centered and holistic treatment options in integrative oncology</i> (U. Wolf, J.M. Fouladbakhsh, M. Wolf) + Rozdz. 51 — <i>Mistletoe therapy in integrative oncology</i> (P. Kechagioglou, N.A. Metri, C.J. Paller)</p> |
| <b>Definicja</b>         | <p>System medyczny rozwijany od początku XX w. przez Rudolfa Steinera i Itę Wegman, łączący medycynę konwencjonalną z antropozoficznym podejściem</p>                                                                                                                             |



## Status w wytycznych

holistycznym. W onkologii kluczowe preparaty: jemioła (*Viscum album*, Iscador®/Helixor®/Abnoba viscum®/Iscucin®).

## Najsilniejsze RCT/dowody

Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. **DEGRO** (Niemcy) — jemioła jako leczenie wspomagające. **Swissmedic** — Iscador refundowany w CH od 2017 r.  $\Delta$

Melzer J. et al. 2009 — przegląd systematyczny n>6800 pacjentów; pozytywne efekty na QoL, niespójne efekty na OS *Forsch Komplementmed* PMID 19729932. Tröger W. et al. — RCT jemioły w raku trzustki — istotne wydłużenie OS *Eur J Cancer* PMID 23994070.  $\Delta$

## OCEBM

2–3 (RCT i przeglądy systematyczne)

## GRADE

Low–Moderate

## Refundacja zagraniczna

**Szwajcaria** — Iscador / jemioła jako część **medycyny antroposoficznej**, od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji; lista BAG: medycyna antroposoficzna, farmakoterapia TCM, akupunktura, klasyczna homeopatia, fitoterapia). **Niemcy** — kontrakty selektywne kas chorych GKV  $\Delta$  (dane refundacyjne wymagają weryfikacji w subzapytaniu v20C-DE). **Holandia** — refundacja w niektórych ubezpieczeniach.

## Status w PL

NIE wymieniona w Stanowisku NRL Nr 2/21/VIII (Test Koniunkcji POZYTYWNY); poza systemem refundacji NFZ; preparaty Iscador/Helixor dostępne tylko przez import lub kliniki integracyjne.

## Potencjalny status w UD207

**WYSOKIE RYZYKO.** Lekarz podający jemiołę pacjentowi onkologicznemu w PL — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna” mimo refundacji w CH/DE. Paradoks UE: ten sam preparat jest standardem w CH od 2017 r., w PL może skutkować sankcją 1 mln zł.

## Wnioski

Klasyczny dowód asymetrii regulacyjnej w UE. Para 2 z Części III v1.0 ilustruje

paradoks vs olaratumab.

*Karta 27 — Ayurveda w opiece onkologicznej*

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 37 — <i>Ayurveda in integrative oncology</i> (S. Narayanan, R. Puthiyedath, A. Dhruva, J.T. Arnold)                                                                                                                              |
| <b>Definicja</b>                  | Tradycyjny indyjski system medyczny rozwijany od ponad 3000 lat. Łączy ziołolecznictwo, dietę, panchakarma (terapia oczyszczająca), jogę i medytację. W opiece onkologicznej stosowana w opiece wspierającej i medycynie integracyjnej. |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>WHO TM Strategy 2025–2034</b> — wsparcie integracji ayurwedy. Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. <a href="#">△</a>                                                                                                                    |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Ograniczone RCT; przewaga obserwacji klinicznych. Ashwagandha ( <i>Withania somnifera</i> ) — RCT w zmęczeniu po chemioterapii. <a href="#">△</a>                                                                                       |
| <b>OCEBM</b>                      | 3–4                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GRADE</b>                      | Low                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | <b>Indie</b> — ayurveda w pełni zintegrowana w systemie ochrony zdrowia (Ministry of AYUSH). USA — programy ayurwedy w <b>Maharishi University i Cleveland Clinic Center for Integrative Medicine</b> .                                 |
| <b>Status w PL</b>                | Brak regulacji; ayurveda jako działalność prywatna/wellness.                                                                                                                                                                            |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>WYSOKIE RYZYKO</b> . Terapeuta ayurwedy bez tytułu medycznego oferujący wsparcie pacjentom onkologicznym — silne ryzyko sankcji UD207.                                                                                               |
| <b>Wnioski</b>                    | System medyczny z 3000-letnią tradycją uznany przez WHO; w PL pełne ryzyko UD207.                                                                                                                                                       |

*Karta 28 — Homeopatia w opiece onkologicznej*

| Atrybut                  | Treść                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b> | Rozdz. 45 — <i>Homeopathy in integrative oncology</i> (Y. Sharma) |
| <b>Definicja</b>         | System medyczny wymyślony przez                                   |

## Status w wytycznych

Samuela Hahnemanna w XIX w., oparty na zasadzie *similia similibus curentur* i potencjalizacji rozcieńczeń. Najbardziej kontrowersyjny system w CIO 2026 — dowody EBM bardzo ograniczone.

Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. **NHMRC Australia 2015** — przegląd negatywny: brak dowodów skuteczności w jakimkolwiek wskazaniu. **EASAC 2017** (European Academies' Science Advisory Council) — krytyczne stanowisko. **Niemcy** — usunięcie homeopatii z koszyka świadczeń publicznych planowane 2024–2025.  $\triangle$

## Najsilniejsze RCT/dowody

Cochrane systematic reviews — brak istotnego efektu klinicznego ponad placebo. Wyjątek: niektóre badania w opiece paliatywnej i w QoL — niejednoznaczne.  $\triangle$

## OCEBM

4–5

## GRADE

Very low

## Refundacja zagraniczna

**Szwajcaria** — od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji; status uzyskany w **referendum z 2009 r.**, 67% poparcie). **Francja** — refundacja stopniowo wycofywana 2019–2021. **Niemcy** — wycofanie z koszyka publicznego planowane 2024–2025. **Indie** — homeopatia zintegrowana w systemie (Ministry of AYUSH).

## Status w PL

Homeopatia praktykowana przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami; preparaty homeopatyczne zarejestrowane w URPL (zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE art. 14 i 16).

## Potencjalny status w UD207

**EKSTREMALNIE WYSOKIE RYZYKO.** Homeopatia ma najsłabsze dowody EBM z 25 metod Części II. Mimo to: (a) preparaty zarejestrowane w URPL; (b) refundowana w Szwajcarii po referendum. Paradoks: status legalny PL  $\leftrightarrow$  ryzyko sankcji UD207 mimo legalnej rejestracji.

|                |                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wnioski</b> | Najślabsze dowody EBM; mimo to status regulacyjny PL/UE skomplikowany. Casus EUropejskiej różnorodności podejść do homeopatii. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IId. Biologically-Based / Diet (Karty 29–33)

### Karta 29 — Dieta i żywienie w opiece onkologicznej

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 41 — <i>Diet and nutrition considerations in integrative oncology</i> (L. Price, J. Dearden, H. Greenlee)                                                                                                                                                                                |
| <b>Definicja</b>                  | Specjalistyczne doradztwo żywieniowe dla pacjentów onkologicznych: dieta przeciwzapalna, dieta śródziemnomorska, dieta roślinna (plant-based), modyfikacje przy malnutrition, sarkopenii, cachexii.                                                                                             |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>ESPEN Guidelines on Nutrition in Cancer Patients 2021. ASCO Survivorship Guidelines. WCRF/AICR Cancer Prevention Recommendations 2018</b> — dieta wpływa na ryzyko nowotworów i przeżycie. <b>WHO/IARC Monographs.</b> <a href="#">Δ</a>                                                     |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | WHEL Study (Pierce J.P. et al.) — dieta bogata w warzywa i owoce w raku piersi <i>JAMA</i> PMID 17635889. WINS Study (Chlebowski R.T. et al.) — dieta niskotłuszczowa w raku piersi <i>J Natl Cancer Inst</i> PMID 17151326. Metaanalizy: dieta śródziemnomorska i przeżycie. <a href="#">Δ</a> |
| <b>OCEBM</b>                      | 1–2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate–High dla prewencji wtórnej                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | Dietetyk jako zawód medyczny w większości państw UE i USA. W PL od 2025 r. dietetyk jako zawód medyczny (ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych).                                                                                                                        |
| <b>Status w PL</b>                | Dietetyk jako zawód medyczny od 2025 r.; specjalizacja w dietetyce onkologicznej.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NISKIE RYZYKO</b> dla dietetyki konwencjonalnej. <b>WYSOKIE RYZYKO</b> dla diet “alternatywnych” (dieta ketogeniczna                                                                                                                                                                         |

## Wnioski

w GBM, post terapeutyczny, dieta surowa, dieta Gerson) — zob. karta 30.

Dietetyka mainstream — niskie ryzyko  
UD207. “Diety alternatywne” promowane jako leczenie onkologiczne — wysokie ryzyko.

## Karta 30 — Post terapeutyczny i dieta naśladowująca post (Fasting-Mimicking Diet)

### Atrybut

### Treść

## Rozdział CIO 2026

Rozdz. 43 — *Fasting and fasting-mimicking diets: Metabolic modulation in cancer therapy* (T.A. Berman)

## Definicja

Krótkoterminowy post (24–72 h) wokół podania chemioterapii lub dieta naśladowująca post (FMD — Fasting-Mimicking Diet, ProLon, opracowana przez Valter Longo, USC) — okresowa redukcja kalorii i białka symulująca efekt postu. W onkologii badana jako modyfikator odpowiedzi na chemioterapię i radioterapię.

## Status w wytycznych

Brak rekomendacji ESMO/NCCN jako standardowe leczenie. **NCI** — wymienia jako kierunek badań. [△](#)

## Najsilniejsze RCT/dowody

de Groot S. et al. (DIRECT trial) — RCT FMD przed/podczas chemioterapii w raku piersi, n=131, *Nat Commun* PMID 32576828 — modulacja toksyczności i odpowiedzi. Mayo Clinic, Memorial Sloan Kettering — trwające badania kliniczne. [△](#)

## OCEBM

2–3 (RCT fazy II)

## GRADE

Low–Moderate (obiecujący kierunek, wymaga walidacji fazy III)

## Refundacja zagraniczna

Brak refundacji; FMD ProLon dostępna komercyjnie.

## Status w PL

Brak regulacji; praktykowana w klinikach integracyjnych.

## Potencjalny status w UD207

**WYSOKIE RYZYKO.** Promocja postu jako “leczenia raka” — bardzo wysokie ryzyko sankcji. Post jako wsparcie chemioterapii (z monitorowaniem) — w polu szarym.

## Wnioski

Aktywny kierunek badań z istotnymi RCT fazy II. Polski system nie ma jasnych granic

dla tego rodzaju interwencji.

*Karta 31 — Kanabinoidy medyczne w opiece onkologicznej*

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 38 — <i>Cannabis and cannabinoids in integrative oncology</i> (D.I. Abrams, S. D'Andre, D. Zylla)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definicja</b>                  | Medyczne stosowanie produktów konopnych zawierających THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol) lub ich syntetycznych pochodnych (dronabinol, nabilon). W onkologii stosowane w bólu nowotworowym, mdłościach pochemioterapeutycznych, jadłowstręcie.                                                             |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>NCCN Adult Cancer Pain Guidelines</b> — kannabinoidy jako część zintegrowanej opieki przeciwbólowej. <b>ASCO Guidelines for the Use of Antiemetics 2020</b> — dronabinol i nabilon w opornym CINV. <b>FDA</b> — dronabinol (Marinol®) zarejestrowany od 1985 r. dla CINV i AIDS-related anorexia. <a href="#">△</a> |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Metaanalizy w bólu nowotworowym — istotna redukcja bólu opornego na opioidy. Metaanaliza w CINV opornym — istotny efekt. <a href="#">△</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>OCEBM</b>                      | 1–2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | <b>USA</b> (~38 stanów) — medical cannabis legalny w onkologii. <b>Niemcy</b> — refundacja przez kasy chorych od 2017 r. <b>Holandia, Czechy, Włochy</b> — refundacja medical cannabis.                                                                                                                                |
| <b>Status w PL</b>                | Marihuana medyczna zarejestrowana od <b>2017 r.</b> (ustawa z 7.07.2017); susz konopny w aptekach na receptę. <b>Refundowana</b> w wybranych wskazaniach (m.in. stwardnienie rozsiane). W onkologii — dostępna na receptę, refundacja ograniczona.                                                                     |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NISKIE RYZYKO</b> — kannabinoidy zarejestrowane w PL od 2017 r. ALE:                                                                                                                                                                                                                                                |

stosowanie “samodzielnych” preparatów CBD z niewiadomego źródła i bez recepty — w polu szarym.

## Wnioski

Klasyczna kategoria medycyny komplementarnej, która przeszła do mainstream PL od 2017 r. Argument: paradoks — kannabinoidy są wyłączone z dyskusji “pseudomedycyny” mimo wcześniejszej kontrowersji.

### Karta 32 — Gut microbiome i probiotyki w opiece onkologicznej

| Atrybut                         | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>        | Rozdz. 49 — <i>Gut microbiome in integrative oncology</i> (J. Lacey, A.M. Stringer, C. Cross, H.R. Wardill)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definicja</b>                | Modulacja mikrobioty jelitowej (probiotyki, prebiotyki, postbiotyki, dieta wysokobłonnikowa, fecal microbiota transplantation — FMT) w onkologii.<br><b>Przełomowa dziedzina 2024–2026:</b> wpływ mikrobioty na odpowiedź na immunoterapię (immune checkpoint inhibitors, ICI).                          |
| <b>Status w wytycznych</b>      | Brak formalnych rekomendacji ESMO/NCCN. <b>Aktywne pole badań</b> — publikacje w <i>Science</i> , <i>Nature</i> , <i>Cell</i> (2022–2026). <a href="#">△</a>                                                                                                                                             |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b> | Gopalakrishnan V. et al. — wpływ mikrobioty na odpowiedź na anti-PD-1 w czerniaku <i>Science</i> PMID 29097493. Davar D. et al. — RCT fecal microbiota transplantation modulujący odpowiedź na anti-PD-1 <i>Science</i> PMID 33542131. Routy B. et al. — <i>Science</i> PMID 29097494. <a href="#">△</a> |
| <b>OCEBM</b>                    | 2–3 (RCT i prospektywne kohorty)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GRADE</b>                    | Moderate (obietujące, wymaga walidacji w większych badaniach)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>   | USA — programy FMT w czołowych ośrodkach (MD Anderson Microbiome Research Center). Probiotyki — bez statusu leczenia onkologicznego.                                                                                                                                                                     |
| <b>Status w PL</b>              | Probiotyki jako suplementy diety; FMT w wybranych ośrodkach w PL w <i>C. difficile</i>                                                                                                                                                                                                                   |

Potencjalny status w UD207

Wnioski

infection.

**NISKIE RYZYKO** dla badań klinicznych z FMT. **WYSOKIE RYZYKO** dla promowania probiotyków jako “leczenia raka”.

Najbardziej przełomowa dziedzina współczesnej onkologii integracyjnej — wpływa na efektywność immunoterapii. Polska regulacja nie nadąża za stanem nauki.

*Karta 33 — Soja i izoflawonoidy w opiece onkologicznej*

Atrybut

Treść

**Rozdział CIO 2026**

Rozdz. 57 — *Soy for prevention and symptom management* (K-Y. Wen, N. Handley)

**Definicja**

Konsumpcja soi i preparatów zawierających izoflawonoidy (genisteina, daidzeina) w profilaktyce nowotworów hormonozależnych (rak piersi, prostata) i w opiece wspierającej (vasomotor symptoms u kobiet po raku piersi).

**Status w wytycznych**

**ACS Guidelines for Cancer Survivors** — soja dietetyczna nie jest przeciwwskazana u survivors raka piersi. **NCCN Survivorship Guidelines** — dieta z umiarkowaną konsumpcją soi bezpieczna. **AICR** (American Institute for Cancer Research) — soja dietetyczna może być korzystna w prewencji.  $\Delta$

**Najsilniejsze RCT/dowody**

Shu X.O. et al. — Shanghai Breast Cancer Survival Study, kohorta n=5042 — istotne związane z konsumpcją soi przedłużenie OS w raku piersi *JAMA* PMID 19996398. Metaanaliza: Nechuta S.J. et al. *Am J Clin Nutr* PMID 22648714.  $\Delta$

**OCEBM**

1–2

**GRADE**

Moderate (dla diety; low dla preparatów wysokoskoncentrowanych)

**Refundacja zagraniczna**

Soja jako dieta — bez statusu leczenia. Preparaty izoflawonoidów — suplementy.

**Status w PL**

Suplementy izoflawonoidów dostępne OTC.

Potencjalny status w UD207

**NISKIE RYZYKO** dla soi dietetycznej. **WYSOKIE RYZYKO** dla promowania



## Wnioski

izoflawonoidów jako “leczenia” raka piersi/prostaty.

Dieta z umiarkowaną konsumpcją soi rekomendowana; preparaty wysokoskoncentrowane — niepotwierdzone.

## Ile. Energy / Other Therapies (Karty 34–38)

### Karta 34 — Healing Touch, Therapeutic Touch, Reiki

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 44 — <i>Healing touch, therapeutic touch, and reiki in integrative oncology</i> (U. Wolf, J.M. Fouladbakhsh, M. Wolf)                                                                                       |
| <b>Definicja</b>                  | Terapie energetyczne polegające na “transferze energii” przez ręce terapeuty (z kontaktem fizycznym lub bez). Reiki — system z Japonii. Healing Touch — system amerykański (American Holistic Nurses Association). |
| <b>Status w wytycznych</b>        | Brak silnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN. Niektóre programy w opiece paliatywnej. $\Delta$                                                                                                                          |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Małe RCT w lęku i bólu — efekty często nieistotne statystycznie ponad efekt placebo lub kontakt terapeutyczny. $\Delta$                                                                                            |
| <b>OCEBM</b>                      | 3–4                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GRADE</b>                      | Low                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | USA — Reiki w programach Memorial Sloan Kettering Integrative Medicine i Dana-Farber Zakim Center (bez refundacji jako “leczenie”, ale jako element komfortu pacjenta).                                            |
| <b>Status w PL</b>                | Brak regulacji; Reiki jako zawód nieregulowany.                                                                                                                                                                    |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>EKSTREMALNIE WYSOKIE RYZYKO.</b> Reiki/Healing Touch jako “leczenie energetyczne” — najwyższe ryzyko interpretacji jako “praktyka pseudomedyczna” w PL.                                                         |
| <b>Wnioski</b>                    | Najslabsze dowody z terapii Części II; jednocześnie używane w czołowych                                                                                                                                            |

amerykańskich ośrodkach jako element komfortu, nie leczenia.

### Karta 35 — Aromaterapia w opiece onkologicznej

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 36 — <i>Aromatherapy in integrative oncology</i> (M. Frenkel, Y. Freed)                                                                                                |
| <b>Definicja</b>                  | Stosowanie olejków eterycznych (lawenda, mięta, imbir, cytryna) inhalacyjnie lub przez masaż w opiece pacjenta onkologicznego — głównie w mdłościach, lęku, zaburzeniach snu. |
| <b>Status w wytycznych</b>        | Brak silnych rekomendacji ESMO/NCCN. <b>NHS UK</b> — aromaterapia w hospicjach onkologicznych. <a href="#">△</a>                                                              |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Małe RCT w mdłościach pooperacyjnych (lawenda, mięta) — niejednoznaczne. Cochrane — ograniczone dowody. <a href="#">△</a>                                                     |
| <b>OCEBM</b>                      | 3–4                                                                                                                                                                           |
| <b>GRADE</b>                      | Low                                                                                                                                                                           |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | UK — aromaterapia w hospicjach onkologicznych (Macmillan).                                                                                                                    |
| <b>Status w PL</b>                | Brak regulacji; aromaterapia jako działalność wellness.                                                                                                                       |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>WYSOKIE RYZYKO.</b> Aromaterapeuta oferujący “wsparcie onkologiczne” — wysokie ryzyko sankcji.                                                                             |
| <b>Wnioski</b>                    | Słabe dowody; w UK refundowana w hospicjach jako element komfortu.                                                                                                            |

### Karta 36 — Muzykoterapia w opiece onkologicznej

| Atrybut                    | Treść                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>   | Rozdz. 52 — <i>Music therapy and music medicine in cancer care</i> (A. Ricciarelli)                                                                                                                                           |
| <b>Definicja</b>           | Profesjonalna interwencja kliniczna z wykorzystaniem muzyki w opiece onkologicznej — dla redukcji lęku, bólu, mdłości, w opiece paliatywnej. Prowadzona przez certyfikowanego muzykoterapeutę (Music Therapist, MT-BC w USA). |
| <b>Status w wytycznych</b> | <b>ASCO/SIO Joint Guideline 2022</b> — muzykoterapia rekomendowana w lęku                                                                                                                                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | okołooperacyjnym i opiece paliatywnej (moderate strength). <a href="#">△</a><br>Bradt J. et al. — Cochrane systematic review of music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients <i>Cochrane Database Syst Rev</i> PMID 27524661. <a href="#">△</a> |
| <b>OCEBM</b>                      | 1–2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | <b>UK NHS</b> — muzykoterapia w hospicjach i opiece paliatywnej. <b>USA</b> — programy w MSK, Dana-Farber, Mayo.                                                                                                                                                                            |
| <b>Status w PL</b>                | Muzykoterapeuta jako zawód nieregulowany; programy w niektórych szpitalach onkologicznych i hospicjach.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NIEPEWNE.</b> Muzykoterapeuta w podmiocie leczniczym — niskie ryzyko. Muzykoterapeuta w gabinecie prywatnym z reklamą “leczenia onkologicznego” — wyższe ryzyko.                                                                                                                         |
| <b>Wnioski</b>                    | Silne dowody; rekomendacja ASCO/SIO 2022. W PL granica regulacyjna nieostra.                                                                                                                                                                                                                |

#### *Karta 37 — Terapie ekspresyjne (pisanie, taniec/ruch, journaling)*

| Atrybut                         | Treść                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>        | Rozdz. 40 — <i>Medical dance/movement therapy</i> (S. Tortora, K. Bryl, J. Whitley) + Rozdz. 42 — <i>Expressive writing and journaling</i> (G. Lopez, C.R. Powers-James, M. Cavazos)                   |
| <b>Definicja</b>                | Terapie ekspresyjne wykorzystujące pisanie (expressive writing, journaling, Pennebaker paradigm) lub taniec/ruch (medical dance/movement therapy) w przetwarzaniu doświadczenia choroby onkologicznej. |
| <b>Status w wytycznych</b>      | Brak formalnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN. <a href="#">△</a>                                                                                                                                          |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b> | Pennebaker J.W. — klasyczne badania expressive writing <i>Psychol Sci</i> PMID 11784031. RCT w opiece onkologicznej — ograniczone. <a href="#">△</a>                                                   |

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OCEBM</b>                      | 3                                                                                                                  |
| <b>GRADE</b>                      | Low–Moderate                                                                                                       |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | Programy w czołowych ośrodkach US (MSK, MD Anderson Integrative Medicine).                                         |
| <b>Status w PL</b>                | Brak regulacji; choreoterapia / arteterapia jako specjalizacje psychologiczne i pedagogiczne.                      |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NIEPEWNE.</b> Terapeuta ekspresyjny w podmiocie leczniczym jako element opieki psychologicznej — niskie ryzyko. |
| <b>Wnioski</b>                    | Słabsze dowody; w czołowych ośrodkach US jako element komfortu pacjenta.                                           |

### *Karta 38 — Guided Imagery i Progressive Muscle Relaxation*

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 54 — <i>Guided imagery and progressive muscle relaxation in the management of oncology patients</i> (D. Yateem, S. Alghamdi, S. Dowidar, F. Florida-Chapman, A.J. Qassim, T. Qassim)                                                          |
| <b>Definicja</b>                  | Techniki relaksacyjne: guided imagery — kierowane wyobrażenia z udziałem przewodnika; progressive muscle relaxation (PMR) Jacobson — sukcesywne napinanie i rozluźnianie grup mięśni. Stosowane w lęku, bólu, mdłościach, opiece okołoonkologicznej. |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>ASCO/SIO Joint Guideline 2022</b> — relaksacja (w tym PMR) w lęku (moderate strength). <b>NCCN Distress Management Guidelines</b> — guided imagery i PMR jako interwencje nefarmakologiczne. $\Delta$                                             |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Metaanalizy w lęku i bólu okołoperacyjnym — istotne efekty. $\Delta$                                                                                                                                                                                 |
| <b>OCEBM</b>                      | 1–2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | USA — programy w MSK, Dana-Farber. UK — w hospicjach.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Status w PL</b>                | Stosowane przez psychologów i terapeutów; brak formalnej rejestracji jako odrębne metody.                                                                                                                                                            |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NISKIE RYZYKO</b> w gabinecie                                                                                                                                                                                                                     |

## Wnioski

psychologa/psychoterapeuty.

Silne dowody, rekomendacja ASCO/SIO; w PL część praktyki psychologicznej.

## II. Special Populations (Karty 39–40)

### Karta 39 — Pediatria onkologia integracyjna

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 62 — <i>Pediatric integrative oncology</i> (J.M. Pope, M.J. Bombacie, H. Hirsch, K. Bouvet, N. Barua)                                                                                 |
| <b>Definicja</b>                  | Onkologia integracyjna specyficznie dla dzieci i młodzieży chorych na nowotwory — adaptowane metody opieki wspierającej (akupunktura, masaż, joga, muzykoterapia, mindfulness, arteterapia). |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>COG</b> (Children’s Oncology Group) — programy integrative w supportive care.<br><b>St. Jude Children’s Research Hospital</b> — Integrative Medicine Program. <a href="#">△</a>           |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Akupunktura w CINV pediatrycznym — Cochrane reviews. Hipnoza w bólu proceduralnym dziecięcym — silne dowody. <a href="#">△</a>                                                               |
| <b>OCEBM</b>                      | 2                                                                                                                                                                                            |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate                                                                                                                                                                                     |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | USA — Integrative Medicine programs w St. Jude, Boston Children’s, CHOP, MSK Kids.                                                                                                           |
| <b>Status w PL</b>                | Onkologia dziecięca w PL nie ma formalnych programów integrative; dzieci leczone w jednostkach pediatrycznych według standardowych protokołów.                                               |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>WYSOKIE RYZYKO przy szerokiej interpretacji.</b> Akupunktura/hipnoza/joga u dziecka z nowotworem w prywatnym ośrodku integracyjnym — silne ryzyko sankcji.                                |
| <b>Wnioski</b>                    | Standardem opieki w czołowych pediatrycznych ośrodkach onkologicznych USA; w PL brak takich programów.                                                                                       |

| Atrybut                           | Treść                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozdział CIO 2026</b>          | Rozdz. 64 — <i>Integrative end-of-life care</i> (D. Chiaramonte)                                                                                                                                                           |
| <b>Definicja</b>                  | Onkologia integracyjna w opiece u kresu życia — masaż, akupunktura, aromaterapia, muzykoterapia, mindfulness w hospicjach onkologicznych.                                                                                  |
| <b>Status w wytycznych</b>        | <b>NHPCO</b> (National Hospice and Palliative Care Organization USA) — integrative therapies w opiece paliatywnej. <b>EAPC</b> (European Association for Palliative Care) — wytyczne integrative w opiece u kresu życia. △ |
| <b>Najsilniejsze RCT/dowody</b>   | Liczne kohorty i RCT w hospicjach — masaż w bólu opornym, muzykoterapia w lęku, aromaterapia w dyskomfortcie. △                                                                                                            |
| <b>OCEBM</b>                      | 2–3                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GRADE</b>                      | Moderate                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Refundacja zagraniczna</b>     | <b>UK NHS</b> — therapies refundowane w hospicjach (Macmillan, Marie Curie). USA — Medicare Hospice Benefit pokrywa integrative therapies.                                                                                 |
| <b>Status w PL</b>                | Hospicja onkologiczne — masaż, aromaterapia, muzykoterapia stosowane jako element komfortu pacjenta; finansowanie z NFZ + środki własne organizacji pozarządowych.                                                         |
| <b>Potencjalny status w UD207</b> | <b>NISKIE RYZYKO</b> w hospicjach refundowanych; <b>NIEPEWNE</b> w prywatnej opiece paliatywnej.                                                                                                                           |
| <b>Wnioski</b>                    | Standard opieki paliatywnej w UE i USA; w PL część praktyki hospicyjnej.                                                                                                                                                   |

### CZĘŚĆ III — Paradoks refundacyjny: trzy reprezentatywne pary

(Zachowane bez zmian z v1.0)

Para 1 — Witamina C dożylna (Bodeker PACMAN 2.1) vs Bewacizumab (Avastin) w GBM

Para 2 — Iscador/jemioła (refundacja w CH/DE) vs Olaratumab (Lartruvo) — wycofany

Para 3 — FDA Project Confirm: 30+ wycofanych accelerated approvals

[Pełna treść Części III — zob. Załącznik 3 v1.0]

---

## CZĘŚĆ IV — Wnioski v2.0

### 1. Asymetria standardu dowodowego (z v1.0)

[Zachowane bez zmian z v1.0]

### 2. Brak gradacji dowodów w kryterium UD207 (z v1.0)

[Zachowane bez zmian z v1.0]

### 3. Gradacja dowodowa A-E (NOWE w v2.1, zastępuje gradację „ryzyka UD207” z v2.0)

W v2.1 wprowadzamy **pięcio-poziomową gradację dowodową** zamiast wcześniejszej (subiektywnej) gradacji „ryzyka UD207”. Argument konstytucyjny w nowym ujęciu: **UD207 nie rozróżnia tych 5 poziomów dowodowych — traktuje wszystkie metody w sposób jednakowy, co stanowi naruszenie standardu *lex certa* i testu proporcjonalności.**

**Poziom A — REKOMENDOWANE PRZEZ WYTYCZNE w konkretnych wskazaniach onkologicznych:** - Akupunktura klasyczna w bólu związanym z inhibitorami aromatazy — **ASCO/SIO 2022 Pain Guideline** (DOI 10.1200/JCO.22.01357, PMID 36122322) - Joga w cancer-related fatigue — **NCCN kategoria 1**, NCI PDQ Fatigue (cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/fatigue/fatigue-hp-pdq) - Mindfulness / MBSR / MBSR w lęku i depresji — **ASCO/SIO 2023 Anxiety/Depression Guideline** (DOI 10.1200/JCO.23.00857) - Tai Chi / Qigong w zmęczeniu — **ASCO/SIO 2024 Fatigue Guideline** (PMID 38754041) - Aktywność fizyczna w opiece onkologicznej — **ACSM Roundtable 2019** (PMID 31626055) - Muzykoterapia w lęku okołoperacyjnym — **ASCO/SIO 2023** + Cochrane 2021 (PMID 34637527) - Cannabis/kannabinoidy w opornym bólu nowotworowym i CINV — **ASCO/SIO 2024 Cannabis Guideline** (PMID 38478773), FDA dronabinol od 1985

**Poziom B — DOPUSZCZALNE jako supportive care z umiarkowaną bazą:** - Hipnoza kliniczna w lęku okołoperacyjnym — RCT i przeglądy systematyczne (PMID 25233905 Cramer systematic review) - Masaż onkologiczny w bólu i lęku — Cochrane 2016 (PMID 27258432), kohorta MSK (PMID 15336336) - Guided imagery / Progressive Muscle Relaxation w lęku — NCCN Distress Management - Soja dietetyczna w opiece survivor raka piersi — Shu BCSS PMID 19996398, metaanaliza PMID 23725149 - Dieta śródziemnomorska / przeciwzapalna — WHEL PMID 17635889, ESPEN Guidelines 2021



**Poziom C — EKSPERYMENTALNE / TRANSLACYJNE (obietujące, ale wymagają walidacji):** - Mikrobiota jelitowa i FMT w odpowiedzi na immunoterapię — Science 2018 (PMID 29097493 Gopalakrishnan, 29097494 Routy), Davar 2021 PMID 33542131. **NIE klasyczna CAM** — to obszar translacyjnej immuno-onkologii. - Post terapeutyczny / fasting-mimicking diet w chemioterapii — DIRECT trial PMID 32576828 (de Groot 2020). Faza II — wymaga walidacji. - Witamina C doustna w raku trzustki — PACMAN 2.1 PMID 39369582 (Bodeker 2024). Faza II — wymaga walidacji w fazie III.

**Poziom D — SŁABE lub NEGATYWNE dowody (mimo refundacji w niektórych krajach):** - Homeopatia — NHMRC Australia 2015 (przegląd negatywny), EASAC 2017 (krytyczne stanowisko). Refundacja CH od 2017 — decyzja regulacyjna oparta na referendum 2009, nie na dowodach EBM. - Refleksologia — przeglądy systematyczne wskazują brak przekonującej skuteczności (PMID 21106613, 31783340). - Naświetlanie laserowe krwi (ILIB), galwanoterapia — brak RCT w onkologii.

**Poziom E — BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DANYCH / wymaga dalszej kwerendy:** - Aromaterapia w opiece onkologicznej (poza hospicjami UK) - Healing touch / Reiki / Therapeutic touch - Ayurveda (ograniczone RCT) - Tradycyjne ziołolecznictwo chińskie (Compound Kushen, Astragalus) — dominacja chińskich RCT o niejednorodnej jakości metodologicznej - Manipulacja kręgosłupa w opiece onkologicznej

**Konkluzja:** standard regulacyjny UD207 powinien rozróżniać poziom A (już rekomendowany przez wytyczne międzynarodowe — wykluczyć z zakresu sankcji), poziom B (dopuszczalny pod warunkami świadomej zgody), poziom C (badania kliniczne na specjalnych ścieżkach), poziom D (klauzula informacyjna o jakości dowodów), poziom E (zakaz reklamy jako “leczenia”). **Obecna definicja art. 67zj nie wprowadza żadnego z tych rozróżnień.**

#### 4. Argument *lex certa* (art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP) — wzmocniony w v2.1

Definicja “praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj UD207 jest **strukturalnie nieokreślona** — adresat normy nie jest w stanie *ex ante* przewidzieć, czy stosowanie metody: - rekomendowanej w wytycznych ASCO/SIO 2022 (akupunktura, joga, mindfulness, muzykoterapia) - refundowanej w państwach UE (homeopatia w CH, jemiola w CH/DE, akupunktura w UK NHS, TCM w CH) - standardowo prowadzonej w czołowych ośrodkach onkologicznych USA (MSK, Dana-Farber, MD Anderson, Mayo Clinic) - opisanej w aktualnym podręczniku akademickim Elsevier (CIO 2026)

zostanie zakwalifikowane jako “praktyka pseudomedyczna” przez Rzecznika Praw Pacjenta, wspieranego opiniami 34-osobowej Rady Ekspertów. Standard *lex certa* (wyrok TK z 5.07.2011 r. P 14/10 i in.) wymaga, by norma karząca była **przewidywalna** dla adresata przed wszczęciem postępowania.

#### 5. Postulat — klauzula świadomej zgody jako proporcjonalne narzędzie (z v1.0)

[Zachowane bez zmian z v1.0]

---



## CZĘŚĆ V — Komparatystyka 7 krajów UE/UK (NOWE w v2.2)

### Streszczenie wykonawcze Części V

Niniejsza część prezentuje **modele regulacyjne CAM w 7 państwach UE/EFTA/UK** zweryfikowane w Perplexity v20C + ChatGPT v20C (21.05.2026): Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Austria, Polska. Pokazuje, że \*\*żadne z tych państw nie